

恥骨上膀胱造瘻管放置

病人須知 · 手術前需要知道嘅事

WARWIKI

恥骨上膀胱造瘻管（SPT）係一條軟管，喺下腹恥骨上方開一個小口，直接將膀胱入面嘅尿引流出嚟，唔需要經過尿道。呢份資料解釋點解需要放SPT、點樣準備，同會發生咩事。

關於呢個程序

膀胱負責儲存尿液。當尿液無辦法正常排出，或者尿道需要休息時，可以直接喺下腹放一條尿管入膀胱。SPT唔經過尿道，長期使用比較舒適，對尿道嘅刺激亦較少。

醫療團隊可能會建議你放SPT，原因包括：

- 你自己無辦法排尿，需要引流膀胱
- 手術或受傷後需要讓尿道休息或保護
- 需要長期引流（例如神經性膀胱問題）
- 避免尿道因長期留置尿管而受刺激
- 讓你可以正常性生活，亦可以夾管試排尿

安唔安全？

安全。呢係一個常見而安全嘅程序。醫生會先將膀胱注水令佢脹起，緊貼腹壁，並用超聲波或膀胱鏡引導，確保尿管唔會傷到腸道。常見嘅輕微出血、不適或膀胱痙攣通常好快消退。如果你曾做過腹部或盆腔手術，請事先告知團隊，需要特別注意。

詞彙解釋

恥骨上（Suprapubic）

喺下腹恥骨上方 — 即係尿管穿出嘅位置。

膀胱

儲存尿液嘅器官，排尿前先將尿積喺度。

尿管（Catheter）

用嚟引流尿液嘅軟管。SPT係由腹部穿入，唔係經尿道。

尿道

正常負責將尿排出體外嘅管道，SPT可以繞過佢。

局部麻醉

喺皮膚注射麻醉藥，令該位置唔痛。

鎮靜／麻醉

令你放鬆或入睡（全身麻醉）嘅藥物。

超聲波／鏡頭

用嚟引導尿管安全入位嘅工具（聲波掃描或膀胱內鏡頭）。

膀胱痙攣

膀胱突然收縮嘅感覺 — 術後常見，可以治療。

會唔會痛？ 視乎做法：有啲係用局部麻醉加鎮靜；不少係用**全身或脊椎麻醉**，即係你會瞓著或下身麻木。醫生會告知你用邊種。術後有輕微膀胱痙攣或傷口酸痛屬正常。整個程序大約需要 15–30 分鐘。

點樣準備（手術前）

- **如有要求，帶住脹滿嘅膀胱嚟** — 令放置更安全。醫療團隊可能叫你飲水忍尿，或者喺開始時先注水入膀胱。
- **依從禁食指示** — 如果需要鎮靜或全身麻醉，術前數小時可能唔可以飲食。
- 如果需要鎮靜，請**安排人接送**。

請**提前告知醫療團隊**如果你：

- 曾做過**腹部或盆腔手術** — 疤痕組織可能影響最安全嘅入路
- 正服用**薄血藥**或有凝血問題 — 通常需要術前暫停
- 可能**懷孕**，或有感染、麻醉藥或乳膠過敏

手術過程

- 1 幫你擺好體位，打麻醉藥（局部加鎮靜，或全身／脊椎麻醉），然後清潔下腹準備手術。
- 2 將膀胱注水（如果未夠脹），令佢脹起貼近腹壁，遠離腸道。
- 3 用超聲波及／或膀胱鏡引導，喺恥骨上方切一個小口，將尿管穿入膀胱。
- 4 喺膀胱內為尿管充氣固定，然後接上引流袋。

之後

- 尿液會引流入袋，團隊會教你點護理尿管同皮膚，然後先出院。
- 術後一兩日有輕微酸痛、膀胱痙攣或**尿液帶少量血**係正常。
- **首次換管由醫療團隊負責**，約喺 4–6 週後。如果尿管脫出，要即刻聯絡團隊 — 通道可以喺數小時內閉合。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 尿管**脫出**，或停止引流（袋入面無尿）
- 腹痛加劇、腫脹或大量出血
- 尿液混濁或有異味（可能係感染）

要記住嘅三件事

1. SPT係從下腹小口直接引流膀胱，繞過尿道，長期使用通常更舒適。
2. 準備：如有要求帶住脹滿嘅膀胱嚟、依從禁食指示、安排接送，並告知腹部手術史、薄血藥或懷孕可能性。
3. 手術用麻醉完成，團隊會教你護理尿管，首次換管約喺 4–6 週後。尿管脫出、發燒或無尿引流，請即刻聯絡。